

CONSENTIMIENTO INFORMADO

DECORTICACIÓN PULMONAR Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE FRACTURAS COSTALES en el traumatismo de tórax (evacuación de hemotórax retenido, con o sin reducción y osteosíntesis costal)

Apellido y Nombre	[Apellido y Nombre del paciente]		
DNI	[DNI]	Fecha de nacimiento	[__/__/__]
Edad	[Edad]	Sexo	[Sexo]
Domicilio	[Domicilio completo]		
Obra Social	[Obra Social]	Nº de afiliado	[Nº Afiliado]
Institución / Sanatorio	[Nombre del Sanatorio]	Fecha del acto	[__/__/__]
Médico interviniente	Dr. Pablo Maynard — Cirujano Torácico UBA — M.N. 121828 / M.P. 232938		

1. DIAGNÓSTICO

[Completar diagnóstico específico del paciente — ej.: traumatismo de tórax con fracturas costales múltiples y hemotórax retenido/coagulado / tórax inestable (volet costal) postraumático / hemotórax postraumático sobreinfectado, etc.]

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Bajo anestesia general, se accede a la cavidad pleural —por videotoroscopia (VATS) y/o toracotomía, según la magnitud de las lesiones— para evacuar el hemotórax retenido o coagulado y liberar la corteza fibrosa que restringe la expansión del pulmón (decorticación), producto de la organización de la colección hemática postraumática. Cuando existen fracturas costales múltiples con desplazamiento significativo y/o tórax inestable (volet costal), se procede además a la reducción y fijación (osteosíntesis) de los arcos costales fracturados mediante placas y tornillos específicos para hueso costal, y/o a la resección de fragmentos costales no viables que no puedan fijarse.

3. OBJETIVO Y BENEFICIOS ESPERADOS

Evacuar el hemotórax retenido/coagulado para evitar su organización en fibrotórax y la consecuente pérdida permanente de función pulmonar; controlar el foco infeccioso en caso de hemotórax sobreinfectado (empiema postraumático); y, cuando corresponde, estabilizar la pared torácica mediante la reducción y osteosíntesis de las fracturas costales, mejorando la mecánica ventilatoria, reduciendo el dolor asociado a la inestabilidad costal y facilitando el retiro de la asistencia respiratoria mecánica en los pacientes que la requieran.

4. RIESGOS Y COMPLICACIONES POSIBLES

4.1 Riesgos generales de la anestesia y de la cirugía torácica

- Reacciones a la anestesia general, complicaciones cardiovasculares o respiratorias.
- Sangrado intraoperatorio y/o postoperatorio, con eventual necesidad de transfusión de hemoderivados (frecuentemente ya requerida por el propio traumatismo).
- Infección de la herida quirúrgica.
- Neumonía y/o atelectasia postoperatoria, de particular relevancia en el paciente con contusión pulmonar asociada.
- Arritmias cardíacas postoperatorias.
- Trombosis venosa profunda y/o tromboembolismo pulmonar, con riesgo aumentado en el paciente politraumatizado.

- Insuficiencia respiratoria postoperatoria, con eventual necesidad de asistencia respiratoria mecánica prolongada.
- Necesidad de reoperación.
- Muerte, como riesgo posible de todo procedimiento quirúrgico mayor bajo anestesia general, con mayor probabilidad en el contexto de politraumatismo grave asociado.

4.2 Riesgos de la evacuación del hemotórax y la decorticación pulmonar

- Sangrado por decorticación de superficies inflamadas, coaguladas o friables, en ocasiones con requerimiento transfusional.
- Fuga aérea prolongada por lesión de la superficie pulmonar, agravada por la fragilidad del parénquima contundido.
- Lesión pulmonar adicional durante la manipulación quirúrgica o por los propios fragmentos costales desplazados.
- Edema pulmonar de reexpansión.
- Reexpansión pulmonar incompleta, con espacio pleural residual.
- Persistencia o desarrollo de infección pleural (empiema postraumático), con necesidad de drenajes adicionales o de una nueva intervención.
- Nuevo neumotórax y/o hemotórax en el postoperatorio.

4.3 Riesgos específicos de la reducción y osteosíntesis de fracturas costales

- Malposición, aflojamiento o migración del material de osteosíntesis (placas y tornillos), con eventual necesidad de reintervención para su recolocación.
- Infección del material de osteosíntesis, que puede requerir su retiro.
- Falta de consolidación ósea de los arcos costales fijados (pseudoartrosis costal) o consolidación en posición viciosa.
- Lesión del paquete vasculonervioso intercostal durante la reducción/fijación, con dolor neuropático crónico en el trayecto de la incisión.
- Persistencia de dolor torácico crónico postraumático, independientemente de la correcta realización técnica del procedimiento.
- Estabilidad de la pared torácica insuficiente pese a la fijación, con compromiso residual de la mecánica respiratoria.
- Deformidad estética y/o funcional residual de la pared torácica.
- En pacientes politraumatizados con contusión pulmonar extensa: mayor riesgo de síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), de sepsis de foco pulmonar/pleural, y en general un riesgo anestésico-quirúrgico global aumentado en relación con las lesiones asociadas (no exclusivamente atribuible a este procedimiento).
- Mayor tiempo de asistencia respiratoria mecánica y de internación en los pacientes con tórax inestable extenso, aun habiéndose realizado la fijación costal.

5. ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS

Manejo conservador con analgesia multimodal (incluyendo bloqueos regionales) y kinesioterapia respiratoria intensiva, sin cirugía, en fracturas costales no complicadas o hemotórax de pequeño volumen; colocación de tubo de drenaje pleural exclusivo (avenamiento) sin decorticación quirúrgica cuando el hemotórax es evacuable por este medio y no se encuentra retenido/organizado; en el tórax inestable, ventilación mecánica prolongada como "férula neumática interna" sin fijación quirúrgica de las costillas (con mayor tiempo de asistencia respiratoria, mayor riesgo de neumonía asociada al respirador y de traqueostomía); videotoracoscopia o toracotomía evacuadora sola, sin osteosíntesis costal, cuando la inestabilidad de la pared no es significativa.

6. CONSECUENCIAS DE NO REALIZAR EL PROCEDIMIENTO

Organización del hemotórax retenido en fibrotórax, con atrapamiento pulmonar y pérdida permanente e irreversible de función respiratoria; desarrollo de empiema postraumático con riesgo de sepsis; en el tórax inestable no corregido, mayor tiempo de ventilación mecánica, mayor riesgo de neumonía asociada al respirador, dolor crónico y deformidad de la pared torácica; en los casos más graves, insuficiencia respiratoria que puede comprometer la vida del paciente.

7. DECLARACIÓN DEL PACIENTE

Declaro que el Dr. Pablo Maynard y su equipo me han explicado, en lenguaje claro y comprensible, mi diagnóstico, el procedimiento propuesto, sus beneficios esperados, los riesgos y complicaciones posibles —generales y específicos—, las alternativas terapéuticas disponibles y las consecuencias previsibles de no realizar el procedimiento. He tenido la oportunidad de formular todas las preguntas que consideré necesarias y las mismas fueron respondidas de manera satisfactoria. Comprendo que la Medicina no es una ciencia exacta y que no se me ha garantizado un resultado determinado. En consecuencia, presto mi consentimiento libre, voluntario e informado para la realización del procedimiento descrito en el presente documento, incluyendo los procedimientos anestésicos necesarios para su realización.

8. AUTORIZACIONES ADICIONALES

- ☐ Autorizo la ampliación o modificación del procedimiento planificado si, durante el acto operatorio, surgieran hallazgos imprevistos que a criterio del equipo actuante hagan necesario o conveniente dicho cambio para preservar mi salud o mi vida.
- ☐ Autorizo la administración de hemoderivados (transfusión) en caso de ser necesario.
- ☐ Autorizo el envío de las muestras/tejidos obtenidos a estudio anatomopatológico y, de corresponder, a estudios moleculares/genéticos complementarios.
- ☐ Autorizo la toma de fotografías/videos del procedimiento con fines académicos y/o de docencia, resguardando mi identidad (Art. 8º, Ley 26.529). En caso de no autorizar, tildar la opción correspondiente:
- ☐ No autorizo la toma de fotografías/videos con fines académicos.

9. REVOCABILIDAD DEL CONSENTIMIENTO

Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier momento previo a la realización del procedimiento, sin necesidad de expresar causa y sin que ello genere consecuencia negativa alguna sobre mi atención médica posterior (Art. 10, Ley 26.529).

10. FIRMAS

Firma: _____ PACIENTE — Nombre: _____ DNI: _____	
Firma: _____ REPRESENTANTE LEGAL (si corresponde) — Nombre: _____ DNI: _____ Vínculo: _____	
Firma y sello: _____ MÉDICO INTERVINIENTE	Firma: _____ TESTIGO (opcional) — Nombre: _____ DNI: _____